

• 临床经验 •

基于形气神一体观运用元气形神针法治疗心脏神经症的理论与实践

张继平 祝广钦 孙一珂 王若冲 张金熔 王乐鹏 孙霄 张亚鹏 刘雷蕾
马淑然

【摘要】 本文基于中医学形气神一体观从经筋角度探讨心脏神经症发病机制,提出本病存在形气神三维度整体关系失常,而气血不能正常濡养经筋是其发病的核心病理环节。形之失常为经筋阻滞不通,影响心的气血运行与神之调控;气之失常为气血虚运行不畅,不能正常濡养心之形体、承载心之神明;神之失常为神明调摄失司,不能驭气、控形,从而导致形气神三者关系失调而心脏神经症发病。临床诊治需从形气神一体化角度进行整体诊治。笔者提出以浮针调形为基础、以脐腹针调气为核心、以头针调神为统领的形气神一体化整体调节的治疗策略,以此达到治病求本原则,为心脏神经症的临床诊疗提供新的思路与方法。

【关键词】 元气形神针法; 心脏神经症; 经筋; 浮针; 脐针; 腹针; 头针; 整体调治

【中图分类号】 R249 **【文献标识码】** A doi: 10.3969/j.issn.1674-1749.2025.04.026

心脏神经症属于躯体神经障碍中躯体形式自主神经紊乱,且主要表现在心血管循环系统的一种病症^[1],又称为心脏神经官能症^[2],其临床不仅有心悸、胸闷、胸痛等循环系统症状,还常伴失眠、焦虑及抑郁等精神症状。现代医学认为其发病与多种因素有关,谢占清等^[3]认为经筋与该病的发生密切相关;黄敬伟亦在《经筋疗法》中称心脏神经官能症为“筋性类冠心病”^[4];亦有学者^[5]认为心脏康复理筋为要。因此,笔者基于经筋理论对该病因病机进行剖析,认为本病存在形、气、神三方面失常的整体变化,基于形气神一体观从形气神同调的角度论治心脏神经症,可为临床诊疗提供新思路。

基金项目: 北京中医药大学 2023 年度基本科研业务费项目(2023-JYB-JBZD-039);北京中医药薪火传承“新 3+3”工程(京中医药科字(2023)126 号)

作者单位: 102488 北京中医药大学中医学院 张继平(硕士研究生)、祝广钦(博士研究生)、孙一珂(博士研究生)、王若冲(博士研究生)、张金熔(硕士研究生)、王乐鹏(博士研究生)、张亚鹏(博士研究生)、刘雷蕾、马淑然;中国中医科学院广安门医院代谢病研究所 孙霄(博士研究生)

作者简介: 张继平(2000-),2023 级在读硕士研究生。研究方向: 元气形神针法治疗筋膜炎症理论与临床。E-mail: zhang_153189@163.com

通信作者: 马淑然(1964-),博士,教授,博士生导师。研究方向: 元气形神针法治疗筋膜炎症理论与临床。E-mail: mashuran64@sina.com

1 心脏神经症的发病存在形气神三方面整体关系的失常

心脏神经症属现代医学命名,依其症状可将其归属于中医“心悸”“胸痹”“郁证”“脏躁”等范畴^[6],经筋研究学者认为本病存在结筋病灶点^[7],阻碍气血运行,且临床上施以松解筋结等推拿理筋手段,配合针灸治疗效果良好。笔者从其病位经筋与症状入手分析,认为本病存在形气神失常的整体病变^[8]。

1.1 经筋阻滞不通是心脏神经症发病的基本病机

经筋阻滞不通的主要外因是六淫侵袭。六淫之气可通过“皮部—经筋”系统侵袭人体,留注肌肉筋膜,造成经络壅塞,气血不通,周身肢体皮部及经筋挛急失养,诱发多种经筋相关痛病,如《素问·痹论篇》“风寒湿三气杂至,合而为痹”之论。《灵枢·邪客》也云“诸邪之在于心者,皆在于心之包络”,说明邪气侵袭心时,心包受之影响更甚,包络功能失常,心包经筋失畅,气血阻于胸背经筋会导致胸部疼痛。同时,因心包经筋的紧张阻塞等,手厥阴心包经及其经筋两侧的太阴肺经与少阴心经及其经筋亦会受到影响,累积加重会出现胸闷憋喘^[9]与心悸怔忡等症状,便会发为心脏神经症。

现代医学普遍认为经筋是统括肌腱、筋肉、韧带及筋膜等不同结构的混合体^[10],正如联系全身的支架网络系统^[11],心脏包膜相关系统是其重要组成部分。从实体结构上看,胸背经筋的挛缩异常会压迫心包,造成心包经筋紧张,心包经之气血滞于胸部,发为本病;其它参与胸廓维持的经筋组织,其功能异常亦会影响到胸廓的功能与结构,进而压迫心包,影响到胸廓内的脏器,出现憋闷、疼痛等症状^[12]。可见心脏神经症发病的直接病机,首在于经筋阻滞不通。

1.2 气血虚弱不行是心脏神经症发病的核心病机

《灵枢·本藏》云“血和则经脉流行，营复阴阳，筋骨劲强，关节滑利矣”，强调了经筋之强盛依赖于气血的濡养。经筋作为气血运行之通路，气血虚弱不行，则筋肉功能不利，局部易出现紧张、僵硬、疼痛等问题，继而经筋内出现筋结、横络等病理产物，反而进一步阻塞气血运行^[3]，《灵枢·经筋》载“太阴之筋……支转筋痛甚成息贲”，“手少阴之筋……其病内急心承伏梁”，大都强调胸部经筋久失气血濡养，多会出现心悸、胸闷等心脏神经症表现。

现代诸多医家亦重视气血虚弱在心脏神经症中的重要性，程伟等^[4]研究心脏神经症的证候规律发现本病以气虚为主，其次是血虚；于彦等^[5]认为本病的主要病性为气虚、气滞，气血生化、运行异常不能正常濡养而病；李应东教授^[6]认为本病为本虚标实之证，气血两虚为主要内因，气滞血瘀为其标。可见，气血虚弱不行是心脏神经症发病的核心病机，是本病发病的最关键环节。

1.3 神明调摄失司是心脏神经症发病的重要病机

神调控形，如得心应手，经筋随人的意志行动，亦随人的意志发病。情志异常会导致五脏气机升降失常，发为经筋病。如《灵枢·百病始生》云“若内伤于忧怒，则气上逆，气上逆则六输不通，温气不行，凝气蕴里而不散，津液涩渗，著而不去，而积皆成矣。”七情内伤，气机逆乱，膻穴气机不利，阳气不能正常运行，则经筋内津液涩渗，积聚而病，而人体内多条经筋循行经过胸前后背，气血严重滞涩胸背经筋，不通不荣，便发为心脏神经症。《杂病源流犀烛·心病源流》亦指出“总之七情之由作心痛”，强调了七情，即“神明调摄失司”，在心脏神经症发病中发挥的作用。

现代医学亦认为，情志不遂会影响神经系统的功能^[7]，故言本病多由中枢神经功能失调，影响自主神经的功能，出现一系列心血管相关症状^[8]。有研究表明，经筋与调节心脏功能活动的自主神经关系密切，情志内伤，气血失序，经筋阻塞，累及自主神经，便会引发心悸、胸闷等，发为本病^[9]。可见，神明调摄失司是心脏神经症发病的重要病机，不容忽视。

1.4 形气神三者相互影响，共同致病

有学者研究经筋是神经中枢调控整合人体结构内力、呈连续网络功能结构的系统组织，是人体形与神、身与心信息互动的重要结构基础^[10]。因此，经筋是形气神三者沟通对话的桥梁。

《淮南子·原道训》言“夫形者生之舍也，气者生之充也，神者生之制也。一失位则三者伤矣。”形气神关系的割裂失调是生命活动失序失稳的关键因素^[11]。心脏神经症患者便存在形气神三方面失调的问题，在形的方面主要是经筋痹阻，在气方面则为气血不濡，在神方面存在神失清明的问题，三者常相兼为病，如胸背和手厥阴经筋失养、挛缩、结块等会压迫胸廓结构，出现胸部憋闷、疼痛等“形—气”失调相关症状；心包经失濡养、紧张痉挛则会牵连至心脏包膜，挛缩压迫之后会有心悸、心烦等“形—气—神”失调相关表现，三

者失调，互为因果而形成恶性循环，最终出现形气神同病的整体性病变，即发为心脏神经症。

2 治疗心脏神经症应以形气神同调为关键

心脏神经症之发病存在形、气、神三方的失调，故诊疗时需形气神三者同调，以达整体诊疗，治病求本。

2.1 调形为基础

心脏神经症患者虽循环系统检查无异常，心脏亦无器质性改变，但仍能在胸背相关经筋处摸索到阻塞气血运行的筋结、横络等结筋病灶点，故仍需重视调形，以此为基础，采用解结之法，舒筋通络，疏通气血通道之经筋。在这一点上，基于经筋理论进行调形的治疗思路与目前临床上应用血管紧张素转化酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitors, ACEI)来治疗高血压、心衰的原理不谋而合。ACEI 用药后能使外周血管扩张，降低血压，也可以减轻心脏前后负荷，用以治疗高血压和心衰。调形治疗与此有异曲同工之妙，通过解结治疗，解除结筋病灶点，缓解经筋紧张痉挛以疏通气血，来达到治疗心脏神经症的目的。谢占清等^[12]在临床上使用针法解结治疗心脏神经症，疗效显著。

2.2 调气为核心

本病之中心环节在于气血不濡，然患处经筋可因通道之经筋阻塞而出现气血瘀滞，经筋失养，亦可因气虚无力鼓动行血而滞。因而，需要激发元气治疗气虚不运导致的阻塞，同时通过输布气血至病处来濡养经筋与行气通瘀，激动元气与输布气血并举，进行联合治疗是取得速效的关键。王亚萍等^[13]便是从气血论治本病，用血府逐瘀汤合针刺疗法治疗效果显著。

2.3 调神为统领

《黄帝内经》强调神的重要性，如《素问·汤液醪醴论篇》云“精神不进，志意不治，故病不可愈”，故诊治需高度重视神的调养。本病患者常伴有情志、精神方面的问题，因此，要注重患者情绪调节。首先，予患者安神定志，调畅情绪，以防止气机失调，津液失序。临床上常采用药物配合心理疗法治疗本病，较单独用药疗效明显^[14]；其次，要激发神之作，统领全身，顺气机之序；最后，则是精神放松导引气机使机体放松，从内部给予经筋一个放松的力，辅助调形，松懈筋结。这一治疗思路与目前临床上使用镇静剂、植物神经调节剂来治疗心血管疾病的原理殊途同归。调神疗法予患者安神定志，放松全身可达相同作用。

2.4 运用元气神针法进行形气神三者同调是治疗心脏神经症的针灸新思维

对于本病患者，调形可选用浮针激动卫气循行，从而推动津液的循行，改善气滞血瘀津凝的状态，消除紧僵硬滑的筋肉的形体病变。调气则可选用脐腹针，激动元气、调节营气输布，从而改善血液的循行输布状态，促进气血四布周身。调神则是用头针针刺头部诸穴，安神定志、醒脑开窍、振奋神明，从而发挥神机调控人体气血津液运行的作用。

上述各个针法已经过多年临床疗效验证，然就单一针法

作用于本病而言,仍不够全面,未能符合人体复杂开放巨系统所发生的形气神三维度的异常变化,难以对本病进行全面有效的调控。马淑然教授^[24]在形气神一体化调节的元整体调节思想指导下,经多年临床实践,提出元气形神针法便可用于本病治疗,该针法将浮针、脐针、腹针、头针有机串联在一起,益气、调神、正形三位一体多层次进行系统整体调节,补充动力,调节功能,恢复结构,三管齐下可为本病患者提供立体化、三维度的整体有效的治疗手段,以此可达治病求本之途。

3 元气形神针法治疗心脏神经症的思路与方法

3.1 浮针调形——舒筋通络,疏通气血运行之路

运用浮针可调整经筋的形态,使筋结、条索、斑块等紧僵硬滑异常形态和感觉恢复正常,有效改善肌张力,放松痉挛肌肉^[25],改善局部血流,可适用于肢体疼痛、内脏痛等各类疼痛性疾病的治疗^[26],以此来调形,可令通道无阻,气血顺畅。

就患者而言,予浮针在前胸、后背、上下肢寻找肌筋膜疼痛点,以心、心包、肺经筋及胸背相关经筋上的肌肉筋膜为主要治疗对象,其重点患肌为心、肺经筋上的肱桡肌、肱二头肌、胸小肌、胸大肌以及背部菱形肌等,松解其上的结筋病灶点,解除病变筋膜,恢复气化过程,并可根据不同证型配合其它经筋辅助治疗,在扫散过程中配合再灌注活动,可达活血化瘀、舒筋通络的效果,能够有效改善局部血流量,放松局部肌肉,调整胸廓结构,治疗缺血失养肌肉痉挛所导致的胸部疼痛。

3.2 脐腹针调气——激动元气,输布气血

腹部有“阴脉之海”任脉,调节阴经气血,有“血海”冲脉,调节十二经与全身气血,脐通百脉,可用脐针激动元气、调动全身气机,腹针调节人体气血输布^[27],如《医学源始》言“脐者,肾间动气也,气通百脉,布五脏六腑,内走脏腑经络。”脐腹针合用可加强促进气血的循环输布,疏通患处气血,使人体气血畅行。

就患者而言,用脐针治疗结合九宫八卦理论可激动元气,推动人体整体气血的循环,帮助改善心脏功能,治疗心悸疗效显著^[28],可针刺震、坎、艮、离、坤、兑位,即肝、肾、胃、心、脾、肺,激发元气,扶正祛邪,助气血输布与水液代谢;腹针针刺“引气归元”(中脘、下脘、气海、关元“腹四关”(滑肉门、外陵)等以输布气血,通达三焦,再针上风湿点和上风湿点上点、上风湿外点,将经气引导至上肢,疏通阻塞的手三阴经筋与胸背经筋。现代腹针研究表明,腹针还可提高患者运动功能及改善患者心理障碍,兼顾形气神三者调治^[29]。

3.3 头针调神——统领全身,安神定志,放松筋肉

《素问·宝命全形论篇》指出“凡刺之真,必先治神。”《灵枢·本神》亦云“凡刺之法,必先本于神。”神作为一身之主宰,有着调控形与气的作用^[30],人的精神意识对人体生命活动具有主导和调控作用^[31]。如《类经·针刺类》云:“医必以神,乃见无形,病必以神,血气乃行,故针以治神为

首务。”神调则形与气顺,经络经筋通畅,气血和调。

头为精明之府,诸阳之会,故头针可激发十二经气,增强神调控气机、统领全身的作用,可增强机体自愈、输布气血。目前研究表明,头针可调节血液循环,治疗神经功能障碍,改善精神情感障碍^[32];头针针刺可提高神经元对肢体肌肉的支配作用,进而平衡肢体肌张力,改善运动状态^[33],故配合头针可安神定志,调治神经,还可放松筋肉,从身体内部给予病变筋肉一个恢复的力量,促进调形。亦有研究表明,针刺调神可以改善血流,促进缺血区血流,增加心肌细胞缺氧耐受,帮助疏泄情志,达到形神兼顾的作用^[34]。

就患者而言,用头针针刺百会、神庭、本神、印堂穴等穴位,可达安神镇静、身心同调,促进神经恢复等作用^[34],激发神调控人体之形、气的作用,调整筋肉,促进形体经筋病变恢复,同时激发头部经气调畅气机,将气血输布全身,减轻情绪问题,促进人体整体气机的恢复与疾病的治愈。

3.4 元气形神针法——形气神三者同调是心脏神经症的重要方法

元气形神针法予患者整体治疗,用浮针调形,恢复患肌,通气血运行之路;脐腹针调气,激动元气,调整气血在三焦运行通畅,使筋肉得以濡养,无“不通”与“不荣”;头针调神,统领全身气机,安神定志,辅助调形。形气神三者同调,整体系统分层次调治,从而有效改善经筋功能,调畅气血,安神定志,达到整体诊疗、治病求本之效果。

4 结语

元气形神针法治疗心脏神经症有着独特优势,形气神一体观理论为本病的论治提供了理论基础,元气形神针法提供了切实有效的诊治手段,以此可调整经筋结构、恢复患肌功能,调畅整体气机,调节精神情志,即形、气、神同调,从而达到“以平为期”的诊疗目的。

参 考 文 献

- [1] 戚国庆,刘坤申,张密林.心脏神经症的诊断治疗进展[J].临床荟萃,2003,18(15):897-898.
- [2] 黄秀华,杨颖,林书宇.中医药治疗心脏神经官能症的研究进展[J].中国中医急症,2022,31(4):737-740.
- [3] 谢占清,王玉双,李晓磊.心脏神经官能症针灸诊治思路[J].中国中医药信息杂志,2016,23(3):110-111.
- [4] 谢占清,李晓磊,王玉双.从经筋角度探讨心脏神经官能症的发病机制[J].环球中医药,2014,7(11):867-869.
- [5] Khan U I,杜廷海,张露苗.心脏康复中药处方的特色分析[J].中医临床研究,2021,13(5):46-47.
- [6] 吴玢金,郑瑀,翟靓帆,等.心脏神经症中医诊疗专家共识[J].世界中医药,2024,19(6):759-762.
- [7] 韩红,王淑娟.经筋病累及病症的现代针灸疗法及机理探讨[J].辽宁中医药大学学报,2008,10(8):12-13.
- [8] 魏雪,董宝强,张文静,等.从经筋理论研究筋性类冠心病概况[J].湖南中医杂志,2018,34(8):203-206.
- [9] 崔祺,邢军,肖蕾,等.浅谈经筋累及病症的针刺治疗体会

- Ⅱ. 中国中医药现代远程教育, 2016, 14(12): 125-127.
- [10] 曹昂焱, 饶毅, 庄威, 等. 经筋实质和治疗应用的探讨 Ⅱ. 针灸临床杂志, 2022, 38(4): 6-9.
- [11] 原林, 王军. 筋膜学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 43-45.
- [12] 赵莹莹, 王家琪, 栾海燕, 等. 中医经筋对人体心功能影响探析 Ⅱ. 空军军医大学学报, 2022, 43(4): 356-358, 364.
- [13] 任标潼, 王树东, 刘润青. 从气血角度论经筋 Ⅱ. 实用中医内科杂志, 2024, 38(10): 69-71.
- [14] 程伟, 邓悦, 陈少军, 等. 心脏神经症中医证候分布规律的研究 Ⅱ. 中国中医药现代远程教育, 2018, 16(11): 152-155.
- [15] 于彦, 付星, 赵军. 论中医对心脏神经症心理因素的认识 Ⅱ. 中国中医基础医学杂志, 2017, 23(8): 1056-1057.
- [16] 刘清君, 刘彩梅, 巩婷. 李应东教授论治心脏神经官能症经验 Ⅱ. 时珍国医国药, 2009, 20(1): 227-228.
- [17] 孟令昊, 马厚芳, 彭思扬, 等. 基于形气神一体论浅探重症肌无力辨治思路 Ⅱ. 中医药学报, 2024, 52(9): 42-46.
- [18] 邵祺腾, 杨秋莉, 杜渐. 中西医结合治疗肝郁气滞型心脏神经症的研究进展 Ⅱ. 实用中医内科杂志, 2012, 26(18): 1-3, 5.
- [19] 茹凯, 刘天君. “经筋”实质的系统科学研究 Ⅱ. 北京中医药大学学报, 2010, 33(4): 229-233, 245.
- [20] 张亚鹏, 孙霄, 祝广钦, 等. 基于系统中医探讨形气神一体化的内涵及临床意义 Ⅱ. 环球中医药, 2024, 17(11): 2257-2261.
- [21] 谢占清, 石奇松, 崔立民. 长圆针治疗心脏神经官能症 1 例 Ⅱ. 环球中医药, 2015, 8(5): 607-608.
- [22] 王亚萍, 王萌. 血府逐瘀汤合并针刺治疗心脏神经官能症的体会 Ⅱ. 中国中医药现代远程教育, 2020, 18(13): 123-124.
- [23] 陈军, 王营, 刘芳. 中西医结合治疗心脏神经症近况 Ⅱ. 山东中医杂志, 2011, 30(12): 892-894.
- [24] 胡孙林, 何雪, 孙霄, 等. 元气形神针理论与实践 Ⅱ. 世界中医药-瑞士版, 2023, 3(3): 71-84.
- [25] 王俊翔, 马良宵, 宋越, 等. 浅析运动类针法在痉挛治疗中的意义 Ⅱ. 中国针灸, 2019, 39(12): 1335-1338.
- [26] 朱梅芳, 余航, 张衍辉. 浮针疗法治疗痛症的研究现状 Ⅱ. 江西中医药, 2017, 48(6): 74-76.
- [27] 周炜. 薄智云腹针疗法临床应用探析 Ⅱ. 北京中医药, 2013, 32(2): 104-105.
- [28] 黄素文, 江珂钺, 骆乐. 基于“营卫气血理论”运用脐针“水火既济”法治老年心律失常验案举隅 Ⅱ. 浙江中西医结合杂志, 2024, 34(3): 258-259.
- [29] 王亚辉, 郝淑芹, 常丽静, 等. 早期康复训练联合腹针对脑卒中患者运动功能及心理障碍的影响 Ⅱ. 中国针灸, 2016, 36(6): 577-580.
- [30] 肖微, 周俊. 试论形气神与针灸治疗的关系 Ⅱ. 中华中医药杂志, 2019, 34(10): 4926-4928.
- [31] 章道宁, 李明阳. 形气神三位一体生命观与笛卡尔的二元论生命观 Ⅱ. 中华中医药杂志, 2023, 38(2): 560-563.
- [32] 李益本, 裴亚妮, 欧雪, 等. 焦黎明治疗失眠伴焦虑抑郁状态临床经验摘要 Ⅱ. 中国民间疗法, 2023, 31(16): 47-50.
- [33] 兰玉娟, 王隐羽, 杨硕, 等. 基于“形神一体”理论针刺治疗中风后痉挛性偏瘫的体会 Ⅱ. 中医康复, 2024, 1(4): 58-61.
- [34] 罗雅丹. 疏肝调神针法治气滞心胸型胸痹(稳定性心绞痛) 的临床观察 Ⅱ. 济南: 山东中医药大学, 2021.

(收稿日期: 2024-10-22)

(本文编辑: 李梅)